

迟发性脾破裂的护理观察

留晓静

脾是腹部内脏中最易受损伤的器官,大部分脾破裂伤后 6 h 内出现症状与体征,但少数病人受伤 48 h 后出现症状与体征。该类病人发病凶险,可迅速发生失血性休克,甚至未及抢救而死亡。我院于 1992 年 2 月至 2000 年 8 月共收治外伤性脾破裂 118 例,其中迟发性脾破裂 12 例,经仔细观察和精心护理,均得到及时确诊,并治愈出院。现报告如下。

1 临床资料

本组 12 例,男 8 例,女 4 例;年龄 14~72 岁,平均 32 岁。其中车祸伤 6 例,挤压伤 2 例,坠落伤 2 例,棒击伤 2 例。受伤到确诊 2 d 6 例,3 d 3 例,5 d 2 例,7 d 1 例。合并脑挫裂伤 3 例,肋骨骨折 4 例,骨盆骨折 2 例。

2 护理观察要点

2.1 严密观察生命体征 腹部损伤的病人,生命体征的变化是判断腹部脏器破裂的重要指征。应及时准确监测血压、脉搏、呼吸,每 15 min 一次,为脾破裂早期诊断提供确凿证据。本组 1 例,因坠落致左季肋部和左下肢受伤入院。第 2 天,当班护士发现脉搏细弱,120 次/min,血压 60/46 mmHg,考虑失血性休克,立即报告医师,行左上腹穿刺,抽取不凝固血 5 ml。急诊剖腹探查,发现脾破裂,行脾切除和腹腔冲洗术。

2.2 严密观察腹部体征 本病隐蔽,在观察生命体征的同时,密切观察腹部体征十分重要,一般每 30 min 一次。注意腹部疼痛的性质和程度,腹肌的紧张情况,压痛与反跳痛的范围,有无移动性浊音。如有持续性左上腹疼,进行性加重,腹肌紧张,压痛反跳痛,应高度怀疑脾破裂可能,及时报告医师,尽早明确诊断。

2.3 观察面色、神志变化 面色和神志可反映组织灌注量和有效循环血量情况,变化的程度受病情年龄的影响很大。本组 1 例男性,72 岁,因坠落伤致头皮裂伤,脑挫裂伤入院。病人面色苍白,四肢皮肤冷,烦躁不安,尿量减少,认为头皮裂伤失血过多所致。第 5 天病人突发神志模糊,满面出汗,立即报告医生,确诊脾破裂。病人由于年龄大,反应迟钝,合并脑挫伤,临床表现不典型,掩盖了病情变化。

3 体会

脾实质破裂或被膜下破裂,因被膜完整而出血受到限制,临床上将延迟脾破裂严重的血性腹膜炎和血腹征及重度失血性休克和贫血。因此,对闭合性腹部创伤病人,应高度警惕脾破裂迟发的可能性。在护理工作中除详细询问病史外,并仔细观察,精心护理,及时准确为医生提供早期病情变化的信息,并随时做好各种抢救准备,分秒必争,积极配合医生,为抢救病人的生命取得宝贵时间。

作者单位:325300 浙江文成县人民医院外科

(2002-05-17 收稿)

药物相互作用引起输液反应的分析

许敬菊 李祥英

当前静脉输液都采用密闭式一次性输液器,输液反应发生率明显下降,但临床上还时常有散在性输液反应。我们对两年来发生的 20 例输液反应进行追踪检查,通过检验、分析,结果证明输液反应除了热原、微粒引起者以外,药物相互作用也可以引起输液反应,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 本组 20 例中男 15 例,女 5 例;年龄 8~68 岁。上感 4 例,肝炎 3 例,肺炎 8 例,上消化道出血 2 例,脑栓塞 3 例。

1.2 材料

1.2.1 鲎试剂 规格 0.1 ml/支,灵敏度 0.5 EU/支,批号:990331;内毒素 I 作标准品效价,1 EU/支,批号:981124;细菌内毒素检查用水,批号:990210。以上鲎试验材料均系湛江安度斯生物有限公司提供。

1.2.2 反应液 病人输液后出现寒战、发热的剩余液体 20 份。

1.2.3 原液 未加药物的液体(0.9% NaCl、5% GS、10% GS、复方氨基酸等)。

1.3 方法 将输液反应时间、反应液体批号、输液器批号、所加药物等进行详细填表同反应剩余液送至本院药检室,按照《中国药典》2000 年版二部附录细菌内毒素检查法进行鲎试验监测。

2 结果

输液反应调查检验结果见表 1。

表 1 输液反应调查检查结果

加入主药	n	未加原液	输液器 鲎试验	反映液鲎试验		反映液微粒检测	
				阴性例	阳性例	微粒合格例	微粒不合格例
氨苄青霉素	4	—	—	4	0	4	0
胞二磷胆碱	2	—	—	1	1	2	0
复方氨基酸	4	—	—	3	1	4	0
病毒唑	4	—	—	4	0	3	1
洁霉素	3	—	—	3	0	3	0
川芎嗪	3	—	—	3	0	2	1
合计	20	—	—	18	2	18	2

注:鲎试验阴性,微粒合格例;符合 2000 年版药典

2.1 对未加入药物的原液进行鲎试验均为阴性,未用同批号一次性输液器检验均符合规定。

2.2 临床症状调查分析 20 例剩余液的反应特点是散在性的,2 例鲎试验阳性者的临床表现比较严重,表现为寒战,高热达 38.5℃~40.7℃,口唇紫绀,烦躁不安,四肢发冷,面色苍白,脉搏细速,血压下降呈休克状态,属于热原反应,经过静注地塞米松,静滴多巴胺,给氧吸入处理,逐渐好转。2 例微粒不合格临床反应较轻微,表现为头晕、头痛、胸闷、恶心、

呕吐、畏寒、发热(37.6℃~39.1℃)等,立即停药,肌注非那根,静滴地塞米松,经过对症处理后 3~5 d 症状消失。通过细致询问病人病史,进行详细的调查分析,认为 16 例病人的输液反应是属于药物相互作用引起的反应。

3 对策

3.1 操作时严格遵守无菌操作规程,防止输液过程中污染。

3.2 认真检查输入的药液、输液瓶应无裂纹或破损,瓶签字迹要清楚,应标明批准文号及生产日期、有效日期,以备待查。

3.3 严格执行药典关于药物配伍禁忌的规定,尽量避免或减少输液时加入多种药物,防止药物配伍不合理引起物理化学性质改变的反应。

3.4 采用一次性密闭式输液,输液器必须有安装好的微孔过滤器,避免异物进入体内。

3.5 建立输液反应报告制度,认真填写记录,包括疾病、输液名称、批号、生产厂家、输入量、剩余量、加入药物名称及数量,以便追踪检查,综合分析,准确判断原因,从而采取有效措施。

(2002-04-21 收稿)

注射用头孢曲松钠与盐酸溴己新禁忌配伍

李梅兰

在我科注射用盐酸溴己新(必嗽平)与头孢曲松钠(菌必治)经常被单独或联合用于治疗呼吸系统疾病。作者观察到两者不能连续静脉滴注,如果连续静脉滴注则发生药物反应。

1 典型病例介绍

病人,男,60 岁。因咳嗽、咯痰 2 周,加重伴发热 2 d,门诊于 2001 年 4 月 25 日收住我科。入院症见:发热(最高体温达 39℃)、咳嗽、咯痰,量少质粘稠,色黄不易咯出,无痰中带血,无粉红色泡沫样痰。乏力,纳差。入院查体:T 38.7℃,P 88 次/min,R 22 次/min,BP 130/86 mmHg。右下肺呼吸音粗,可闻湿性罗音。余(—)。实验室检查:血 RT 示:WBC 11.5×10⁹/L,N 0.83,L 0.17,Hb 135 g/L。胸片 X 线提示:右下肺感染。心电图示:窦性心律,心电图大致正常。拟诊为:右肺炎炎。作者执行医嘱:第一组 5%葡萄糖 250 ml+菌必治 2.0 和第二组 5%葡萄糖 200 ml+必嗽平 16 mg 静脉点滴。当第一组液输完后续第二组(未冲管)约 3 min 后,病人突然出现呼吸困难,烦躁不安,寒颤、四肢冰凉,颜面及颈部出现散在粟粒样红色丘疹,立即停止输液,此时

发现输液管中液体已变为乳白色。嘱病人半卧位吸湿氧,肌注苯海拉明 20 mg,保暖等对症治疗,约半小时后观察病人上述症状缓解。

2 分析与护理体会

2.1 必嗽平溶液为酸性,而菌必治溶液为碱性,当两者联用时,在输液管中一酸一碱溶液发生化学反应。具体发生化学反应及所生成物质由于我们条件和水平所限,对其真正反应未做进一步验证。

2.2 护理人员在执行医嘱时,除严格执行“三查七对”制度,认真查看现有“配伍禁忌表”外,还需了解新药知识及药物配伍禁忌,以避免不知而促发的不良反应。护理人员一定在更换液体后要注意认真观察,避免用惯性思维,误认为二药并未配合在一组内而疏忽再观察造成不该发生的不良反应。总之,护理人员要做到勤观察、仔细认真、一丝不苟。

2.3 护理人员在操作中发现二药连用时液体出现混浊,为了确保病人的安全,尽量避免二药连用。在无法避免的情况下,二药之间可插输少量其它液体(如 5%葡萄糖或 0.9%生理盐水)以冲输液管中剩余药物来避免两者的配伍反应。

(2002-04-09 收稿)